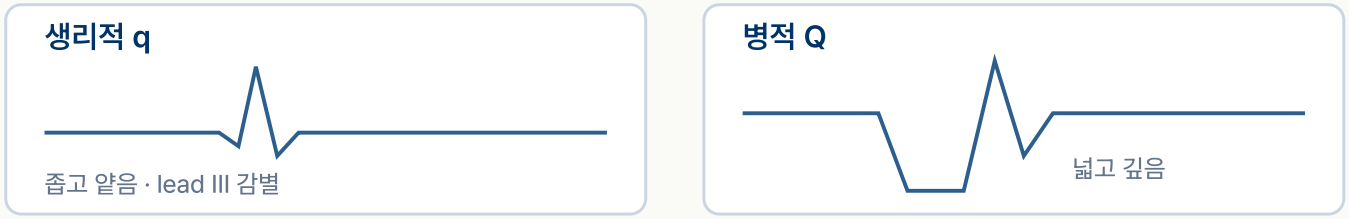
자동판독의 과거 심근경색·병적 Q파를 만났을 때

자동판독 문구를 읽은 뒤, 실제 Q파의 폭·깊이와 생리적 q파를 대조한다.

핵심 판단 한눈에



좁고 얕은 q와 넓고 깊은 Q를 구별한다. 파형은 개념도이다.

원파형에서 확인할 것

구분	강의에서 제시한 특징
병적 Q파 (pathologic Q)	Q 깊이 > R파의 1/4 · 폭 >1 mm (도식: >40 msec)
생리적 q파 (septal q)	좁고 얕은 q. 하벽·측벽 유도, V4–6에서 보일 수 있음
특히 lead III	작은 q파가 생리적으로 나타날 수 있어 pseudo Q와 감별
위치 단서	하벽 유도의 Q: inferior infarct · V1–3의 깊은 Q: anterior infarct

심근경색의 흔적을 찾는 이유

확진된 관상동맥질환·과거 심근경색의 치료로 연결

강의는 aspirin, ACE inhibitor/ARB, beta-blocker, statin을 소개했다. 특히 statin의 재발·관상동맥질환 진행 억제 역할을 강조했다.

진료 중 확인 순서

- ☐ 자동판독의 **"infarct, age undetermined"**와 실제 Q파를 대조한다.
- ☐ 작고 좁은 생리적 q인지, 넓고 깊은 병적 Q인지 구분한다.
- ☐ **관상동맥질환이 증명된 환자** 또는 과거 심근경색 환자의 약물치료를 점검한다.
- ☐ **급성 심근경색은 즉시 의뢰**한다.